SDD 148

Spécialité : Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition

Date : 20/01/2024
Auteur : SAMANNI Léa (DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition, ECN 2023)
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie, ECN 2023), VILLARD Sébastien (DES Médecine interne, ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	ITEM 241-Goitre, nodules thyroïdiens et cancers thyroïdiens
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 148-Goitre ou nodule thyroïdien
Matériel nécessaire à la station	1 bureau et 2 chaises
Contexte de la station	Goître chez une patiente de 73 ans

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Station avec patient standardisé

Vous êtes médecin généraliste en ville.
Vous recevez en consultation dans votre cabinet, Mme. DUGRENIER âgée de 73 ans.
Cette dernière présente un goitre, constaté par son entourage.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Compléter l'interrogatoire de la patiente
- Décrire votre examen clinique thyroïdien et préciser oralement ce que vous recherchez
- Prescrire deux examens complémentaires pour explorer ce trouble

Vous ne devez pas :

- Faire appel à un spécialiste
- Rédiger une ordonnance

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur ses antécédents personnels.	*1 pt*	☐
2.	L'étudiant(e) questionne la patiente sur ses antécédents familiaux.	*1 pt*	☐
3.	L'étudiant(e) recherche une gêne à la déglutition : dysphagie.	*1 pt*	☐
4.	L'étudiant(e) recherche une gêne respiratoire : dyspnée.	*1 pt*	☐
5.	L'étudiant(e) recherche des symptômes d'hyperthyroïdie. ***Au moins 3 pour avoir le point :*** *Palpitations, amaigrissement, accélération du transit, tremblements, nervosité, anxiété, hypersudation/sueurs.*	*1 pt*	☐
6.	L'étudiant(e) recherche des symptômes d'hypothyroïdie. ***Au moins 3 pour avoir le point :*** *Bradycardie, prise de poids, anorexie, constipation, frilosité acquise, peau sèche, dépilation.*	*1 pt*	☐
7.	L'étudiant décrit la palpation thyroïdienne : - *Analyse de la région cervicale ET patient à installer dos à l'examinateur, assis*	*1 pt*	☐
8.	L'étudiant décrit la palpation thyroïdienne : - *Palpation avec les deux mains ET du bout des doigts*	*1 pt*	☐
9.	L'étudiant décrit la palpation thyroïdienne : - *Il demande au patient de déglutir pour suivre l'ascension de la glande thyroïdienne*	*1 pt*	☐
10.	L'étudiant précise qu'il évalue le volume du goitre.	*1 pt*	☐
11.	L'étudiant précise qu'il recherche un ou plusieurs nodules thyroïdiens.	*1 pt*	☐
12.	L'étudiant précise qu'il recherche des adénopathies à la palpation.	*1 pt*	☐
13.	L'étudiant demande la réalisation d'un dosage de la TSH	*1 pt*	☐
14..	L'étudiant demande la réalisation d'une échographie thyroïdienne.	*1 pt*	☐
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

1.	**2. APTITUDE À QUESTIONNER**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

2.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

3.	**5. COMMUNICATION NON VERBALE**	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL (/15 points)	**17 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

<u>Interrogatoire :</u>

- *ATCD personnels et familiaux (caractère souvent familial du goitre ? existence de pathologies thyroïdiennes familiales ?)*
- *Rechercher ensuite une gêne associée à un goitre plongeant : risque de compression oesophagienne, entraînant une dysphagie, et laryngo-trachéale entraînant une dyspnée. (Il existe aussi un risque de compression du nerf récurrent entraînant une dysphonie).*

<u>Palpation thyroïdienne (examen clinique)</u> : bien décrire le geste et ce qu'il recherche

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

<u>Examens complémentaires :</u>

- *Dosage de la TSH pour rechercher une dysthyroïdie (hypo ou hyper fonctionnement de la glande thyroïde) pouvant nous orienter sur différentes pathologies : maladie de Basedow, maladie de Hashimoto, nodule(s) toxique(s)...*
- *échographie thyroïdienne : recherche la présence de nodules et leurs caractéristiques échographiques, apprécie le volume du goitre, et évalue l'état du parenchyme thyroïdien (signes échographiques de thyroïdite par exemple).*

Dans le cadre de cette station : il s'agit d'un goitre multinodulaire toxique.

Chez une patiente jeune, on aurait pu évoquer un goitre simple, favorisé par la carence en iode et le tabagisme (mais aussi un traitement par lithium, la puberté/grossesse et l'existence d'antécédents familiaux de goitre).

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Mme. DUGRENIER 73 ans,
Se présente en consultation de médecin générale devant l'apparition d'un goitre constaté par son entourage.

Plan de la station ECOS :

Patiente simulée, assise en face de l'étudiant.

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Bonjour docteur,
Je viens vous voir parce que mon mari et mes enfants m'ont dit que mon cou avait augmenté de volume ces derniers mois. Je suis un peu gênée pour avaler, mais je n'ai pas mal. ".

Identité du patient :

Mme. DUGRENIER Henriette, 73 ans
Taille : 1,65 m
Poids : 60 kg

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Mode de vie :

Patiente de 73 ans, retraitée, ancienne institutrice.
Vit avec son mari.
Habite en Alsace, dans les montagnes Vosgiennes.
A deux enfants et 5 petits enfants.
Active, fait les courses, le ménage et la cuisine.Pratique la marche rapide.
Tabagisme actif (environ 20 PA)
Consommation alcoolique très occasionnelle.
Pas d'allergie.

Comportement global :

Patiente ayant un bon niveau d'éducation.
Réponds aux questions de manière adaptée.
Très agitée et nerveuse.
Elle demande à plusieurs reprises d'ouvrir la fenêtre pendant la consultation.

Antécédents personnels :

- Fracture du col du fémur droit en 2022 (pose de Prothèse totale de hanche), d'origine ostéoporotique
- Opération bilatérale de la cataracte
- Hémorroïdes
- Hypertension artérielle

Antécédents familiaux :

Ne sait pas

Médicaments :

- Ramipril 2,5 mG : 1 comprimé le matin
- Calcidose-vitamine D3 : 1 sachet par jour
- Risedronate 35 mG : 1 comprimé par semaine, le mercredi

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Symptômes positifs :

- Antécédents personnels : “Je me suis fracturée le fémur l’année dernière et on m’a posé une prothèse de hanche. Sinon j’ai été opérée de la cataracte il y a 5 ans”.
- Antécédents familiaux : “Je ne sais plus docteur, franchement”
- Si l’étudiant(e) recherche une gêne à la déglutition : “Non”
- Si l’étudiant(e) recherche une dyspnée : “Non”
- Si l’étudiant(e) recherche des signes d’hyperthyroïdie :
    - Palpitations : “Oui docteur j’ai souvent le coeur qui s’emballe, comme ça, sans rien faire”.
    - Perte de poids : “Ah peut être que j’ai perdu 1 ou 2 kilos depuis l’an dernier”
    - Hypersudation : “Aaaah ça oui par contre, j’ai tout le temps chaud, d’ailleurs vous pourriez baisser le chauffage ?”
    - Agitation/nervosité : “Oui, j’ai la bougeotte, et des difficultés pour m’endormir ces derniers temps”
    - Diarrhées / accélération du transit/tremblements : NON
- Si l’étudiant(e) recherche des signes d’hypothyroïdie : Absents /aucun
- L’étudiant doit décrire la palpation thyroïdienne à l’oral.

Constantes :

- TA : 134/82 mmHg
- FC : 112 bpm
- T°C : 37,2°C

Donnée complémentaire :

Aucune donnée complémentaire

Questions de relance :

- *Pendant la description de la palpation, la patiente peut demander à l’étudiant ce qu’il est en train de faire/de chercher pour l’inciter à bien détailler son examen clinique.*
- **5ème minute** : “Est-ce que vous allez me prescrire des examens complémentaires docteur ?”

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l’accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d’Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)